

Fecha 17/7/2026

Datos personales

Nombre completo Enrique Rezentiz **Expediente** PAC-000007
Edad 24 **Sexo** ☐ Fem ☒ Mas **Edo. civil** ☒ Soltero ☐ Casado **Ocupación** Desarrollador de software **F/N** 15/03/2002
Teléfono 5544332211 **Dirección** Av. Insurgentes Sur 1234, Col. Del Valle, CDMX

Motivos de consulta

Paciente masculino de 24 años que acude a consulta de primera vez en el área de Nutrición, referido por sobrepeso identificado en una revisión médica de rutina realizada por su empresa. Refiere que en el último año ha notado un aumento de peso gradual, de aproximadamente 6 kg, que atribuye a cambios en su rutina laboral tras iniciar un puesto de desarrollador de software con jornadas prolongadas frente a computadora, mayor 123456789123456789

Qx o Tx previos

Sin antecedentes quirúrgicos relevantes. Niega hospitalizaciones previas, fracturas o transfusiones sanguíneas. No refiere tratamientos médicos activos ni consumo crónico de medicamentos de prescripción. Antecedente de valoración por médico general hace aproximadamente ocho meses por astenia y adinamia, con estudios de laboratorio básicos reportados como normales en ese momento; no se indicó tratamiento farmacológico ni

Antecedentes patológicos heredofamiliares

Enfermedades	Madre	Padre	Aa Mat	Ao Mat	Aa Pat	Ao Pat
Diabetes Mellitus	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Obesidad o sobrepeso	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Cáncer	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hipertensión	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Enfermedades Renales	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedades Endocrinas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedad Tiroidea	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedades Psiquiátricas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedades Neurológicas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enfermedades Autoinmunes	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Enferm. Gastrointestinales	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otras: Abuela materna con hipotiroidismo diagnosticado	☐	☐	☐	☐	☐	☐

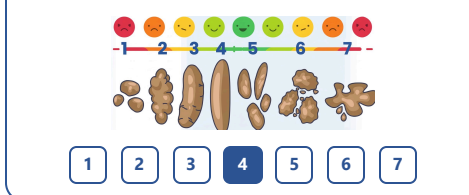
Antecedentes patológicos personales

- ☐ Diabetes Mellitus
☐ Obesidad o Sobrepeso
☐ Cáncer
☐ Hipertensión
☐ Enfermedades Renales
☐ Enfermedades Endocrinas
☐ Enfermedad Tiroidea
☐ Enfermedades Psiquiátricas
☐ Enfermedades Neurológicas
☐ Enfermedades Autoinmunes
☐ Enferm. Gastrointestinales
☐ Otras: Sin otros antecedentes personales patológicos relevantes a la consulta

Sintomatología

Enfermedades	Freq./Cant.
☐ Gastritis	Niega cuadros de c123456789
☐ Colitis	Niega cuadros de colitis
☐ Reflujo gastroesofágico	Niega pirosis o reflujo
☐ Diarrea	Niega, hábito intestinal regular
☐ Estreñimiento	Niega, evacua a diario
☐ Vómito	Niega episodios eméticos
☐ Náuseas	Niega náuseas habituales
☐ Disfagia	Niega dificultad para tragar
☐ Hiperfagia	Niega hiperfagia franca
☐ Flatulencias	Ocasionales, sin relación aparente
☒ Distensión abdominal	Ocasional, después de comer.
☐ Hiporexia	Niega, apetito conservado

Escala de Bristol



Diagnósticos médicos

Riesgo cardiometabólico incrementado por antecedente heredofamiliar materno de Diabetes Mellitus tipo 2 y de Hipertensión arterial.1234567891234567891234
Riesgo cardiometabólico incrementado por antecedente heredofamiliar materno de Diabetes Mellitus tipo 2 y de Hipertensión arterial.1234567891234567891234
Riesgo cardiometabólico incrementado por antecedente heredofamiliar materno de Diabetes Mellitus tipo 2 y de Hipertensión arterial.1234567891234567891234
Riesgo cardiometabólico incrementado por antecedente heredofamiliar materno de Diabetes Mellitus tipo 2 y de Hipertensión arterial.1234567891234567891234
Riesgo cardiometabólico incrementado por antecedente heredofamiliar materno de Diabetes Mellitus tipo 2 y de Hipertensión arterial.1234567891234567891234

Antecedentes personales no patológicos

	Frecuencia	Cantidad
☐ Hábito tabáquico	Niega tabaquismo	No fuma actualmente
☒ Consumo de alcohol	Social, fines de semana	1 a 2 copas por sesión
☐ Consumo de drogas	Niega haber consumido	Niega consumo actual

Medicamentos

Medicamentos	Dosis
Complejo B	1 tableta vía oral cada 24 horas
Omega 3 (aceite de pescado)	1000 mg vía oral cada 24 horas
Vitamina D3	2000 UI vía oral cada 24 horas,
Paracetamol (uso ocasional)	500 mg vía oral cada 8 horas p
Loratadina (uso ocasional)	10 mg vía oral cada 24 horas p

Ejercicio

Realiza ejercicio ☐ No ☒ Sí **Aeróbico** ☒ **Anaeróbico** ☐
¿Cuál? Caminata en terreno plano y trote ligero, principalmente durante los fines de semana
Frecuencia 3 veces por semana, generalmente **Intensidad** Moderada, con percepción subjetiva de esfuerzo
Tiempo 30 a 40 minutos por sesión, con calentamiento **Volumen** Bajo a moderado, con tendencia a aumentar
Progresión Constante, sin incremento reciente

Antecedentes gineco-obstétricos

G N/A de las cuales fueron: **P** N/A **C** N/A **A** N/A **FUM** N/A
Embarazo ☒ No ☐ Sí **SDG** N/A
Reemplazo hormonal ☒ No ☐ Sí N/A
Anticonceptivos ☒ No ☐ Sí N/A

Aspectos dietéticos

Alergias alimentarias:

☒ No ☐ Sí

Cuál

No refiere alergias a medicamentos ni alimentos conocidas.

Intolerancias alimentarias:

☒ No ☐ Sí

Cuál

No refiere intolerancias alimentarias identificadas.

Alimentos de preferencia:

☐ No ☒ Sí

Cuál

Prefiere pechuga de pollo asada o a la plancha, verduras de hoja verde como espinaca.

Alimentos que no le agradan o no acostumbra

Refiere desagrado marcado por el hígado de res y por el pescado con alto contenido graso, así como por vísceras en general; evita también mariscos crudos por preferencia personal.

Comidas al día

3

Fuertes

3

Colaciones

1

¿Quién prepara sus alimentos?

El mismo entre semana; los fines de semana su pareja colabora en la preparación de los alimentos

Ha modificado su alimentación en los últimos 6 meses

☐ No ☒ Sí

Cómo (1 1)

Refiere haber reducido de manera espontánea el consumo de refrescos embotellados y de comida rápida durante el último mes, motivado por el hallazgo de sobrepeso en su re

Indicación de dieta especial/recomendada previamente

☒ No ☐ Sí

Cuál

No ha seguido dietas o planes de alimentación estructurados previos a esta valoración.

Su alimentación dependiendo de su estado de ánimo

☐ No ☒ Sí

Cómo (1 1)

Refiere aumento notable en la ingesta de alimentos, principalmente ricos en carbohidratos simples, durante periodos de estrés laboral intenso

Uso de laxantes

☒ No ☐ Sí

Cuál

No refiere uso de laxantes ni suplementos para el tránsito intestinal.

Uso de medicamentos para bajar de peso

☒ No ☐ Sí

Cuál

No ha utilizado medicamentos ni suplementos específicos para pérdida de peso previamente.

Expediente cargado correctamente

Frecuencia de consumo

Verduras

5

/7 días

Pan dulce UP

/7 días

Carne de cerdo

1

/7 días

Mariscos

1

/7 días

Quesos amr

/7 días

Leche UP

/7 días

Mantequilla

2

/7 días

Jugos nat

/7 días

Gelatinas

1

/7 días

Agua natural

7

/7 días

Fruta*

/7 días

Galletas

1

/7 días

Carne de pollo

4

/7 días

Huevo

5

/7 días

Embutidos

/7 días

Yogurt UP

/7 días

Margarina

1

/7 días

Jugos UP

/7 días

Aguas frutas

/7 días

Papas fritas

2

/7 días

Cereal s/g

/7 días

Leguminosas

3

/7 días

Pavo

1

/7 días

Prod. anim UP

/7 días

Leche s/sab

/7 días

Oleaginosas

2

/7 días

Refresco

3

/7 días

Helado

1

/7 días

Té

3

/7 días

Garnachas com

/7 días

Pan dulce nat

/7 días

Carne de res

3

/7 días

Pescados

2

/7 días

Quesos bcos

/7 días

Yogurt s/sab

/7 días

Aceites

5

/7 días

Agua sab UP

/7 días

Nieve

/7 días

Café

1

/7 días

Garnachas fri

/7 días

Antropometría	VO	Interpretación
Talla (m)	1.75	
Peso (kg)	88	
IMC (kg/m ²)	28.7	Sobrepeso grado I
Peso Ideal/FAO (kg)	74	
Circ. Muñeca (cm)	17	Normal
Diámetro codo (cm)	7	Complexión mediana
Circ. Brazo (cm)	33	Ligeramente aumentado
Circ. Abd (cm)	98	Aumentado
Circ. Cintura (cm)	96	
Circ. Cadera (cm)	102	
ICC	0.94	Riesgo cardiovascular alto
PCB (mm)	12	Normal
PCT (mm)	15	Normal
PCSe (mm)	20	Normal
PCSi (mm)	18	Ligeramente aumentado
% Grasa SIRI	26	Sobre rango saludable
% Grasa InBody	27	Sobre rango saludable
IMG InBody	8.5	Elevado
MLG (kg)	64	
IMLG (kg/m ²)	20.9	Normal
cAMB (cm ²)	45	Normal
MMT InBody	42	Normal
IMEA InBody	8.9	Normal
ACT (L)	38	
Grasa Visc (L)	9	Ligeramente elevada

Interpretación antropométrica

Paciente de sexo masculino con diagnóstico antropométrico de sobrepeso grado I (IMC 28.7 kg/m², clasificación OMS), con incremento de la adiposidad de predominio central evidenciado por una circunferencia de cintura de 96 cm y una relación cintura-cadera de 0.94, ubicada en rango de riesgo cardiovascular alto para el sexo masculino. El porcentaje de grasa corporal estimado tanto por el método de Siri (26%) como por

Signos Vitales	VO	Interpretación
T. Arterial		
F. Resp (rpm)		
F. Card (lpm)		
Temp (°C)		
SO ₂	98	Normal

Parámetros bioquímicos	VO	Interpretación
Glucosa (mg/dL)	92	Normal
Colesterol Total (mg/dL)	198	Limitrofe
HDL (mg/dL)	42	Bajo
LDL (mg/dL)	124	Limitrofe
Triglicéridos (mg/dL)	168	Elevado
Hemoglobina (g/dL)	15.2	Normal
Hematocrito (%)	45	Normal
Creatinina (mg/dL)	0.9	Normal
TSH (μUI/mL)	2.8	Normal
T4 Libre (ng/dL)	1.2	Normal
Sodio (mEq/L)	140	Normal
Potasio (mEq/L)	4.2	Normal
Cloro (mEq/L)	102	Normal
AST/TGO (U/L)	22	Normal
ALT/TGP (U/L)	28	Normal
Fosfatasa alcalina (U/L)	78	Normal
Bilirrubina total (mg/dL)	0.6	Normal
Urea (mg/dL)	28	Normal
Ácido úrico (mg/dL)	5.8	Limitrofe
BUN (mg/dL)	13	Normal
Proteínas totales (g/dL)	7.1	Normal
Albumina (g/dL)	4.3	Normal
Vitamina D 25-OH (ng/mL)	22	Insuficiente
Vitamina B12 (pg/mL)	410	Normal
Ferritina (ng/mL)	65	Normal
Hierro sérico (μg/dL)	85	Normal
Insulina en ayuno (μU/mL)	14.5	Elevada
HOMA-IR	3.3	Resistencia a la insulina

Interpretación bioquímica

El perfil bioquímico muestra glucosa sérica en ayuno dentro de parámetros normales (92 mg/dL), sin evidencia bioquímica actual de alteración en el metabolismo de los carbohidratos, aunque el antecedente heredofamiliar materno de Diabetes Mellitus tipo 2 obliga a vigilancia estrecha. El perfil de lípidos evidencia colesterol total limitrofe (198 mg/dL), HDL bajo (42 mg/dL) y LDL limitrofe (124

Solicitud de análisis

Química Sanguínea

☐ EGO

Biometría hemática

☐ Otro: No se solicitan estudios adicionales por el momento;

ESA: Explorado y sin alteraciones; N/A: No aplica; PN: Preguntado y negado; ✓: Adecuada.

2

Matriz IMG/IMLG

IMLG (kgMG/est ²)	IMG disminuido (≤4 H / <7 M)	IMG adecuado (5-9 H / 7-11 M)	IMG adecuado (5-8 H / 7-11 M)	
IMLG Bajo (<17 H / <15 M)	Caquexia	Desnutrición proteico-energética	Desnutrición proteico-energética	Obesidad preclínica / clínica
IMLG Normal (17-23 H / 15-21 M)	Bajo en grasa	Normalidad	Normalidad	Obesidad preclínica / clínica
IMLG Alto (23-25 H / 21-23 M)	Atletas	Físicamente activa	Físicamente activa	Sano metabólicamente / obesidad
IMLG Muy Alto (25-28 H / 23-25 M)	Sospecha de uso de esteroides / Obesidad mórbida			
IMLG Muy Alto (>28 H / >25 M)	Diagnóstico de uso de esteroides / Obesidad mórbida			

Diagnóstico Matriz IMG/IMLG: Sano, metabólicamente funcional / persona físicamente activa según matriz IMLO/IMG, sin diagnóstico previo de

Expediente cargado correctamente

Hallazgos generales		
Adiposidad	Adiposidad aumentada	Exceso
Músculo		
Cardiovascular		
Respiratorio		
Digestivo		
Edema	Sin edema en extremidades	ESA
Extremidades	Simétricas, sin edema	ESA
Ojos	Conjuntivas rosadas	ESA
Pelo	Cabello con brillo	ESA
Cabeza	Normocéfalo, sin hipertensión	ESA
Manos y uñas	Uñas sin coiloniquia	ESA
Boca / Lengua		
Cuello / Piel		
Dientes	Dentición completa	ESA
Garganta		

Recordatorio de 24 horas

Fecha 17/7/2026

Hora	Contenido (platillo: cantidad y alimento)
07:30	Avena cocida en leche descremada, con un plátano en rebanadas, endulzada ligeramente con canela, acompañada de un vaso de agua natural
10:30	Una manzana mediana en trozos acompañada de 10 almendras naturales sin sal, consumida a media mañana en el trabajo
14:00	Pechuga de pollo asada a la plancha, arroz blanco, ensalada de lechuga y jitomate con poco aceite de oliva, 2 tortillas de maíz y un vaso de agua natural
17:30	Yogurt natural sin azúcar añadida con granola casera y algunas fresas picadas, consumido a media tarde
20:30	Dos quesadillas de tortilla de maíz con queso panela, acompañadas de salsa verde casera y un vaso de agua de jamaica sin azúcar

Alimentos olvidados

- Agua
- Café / Té
- Leche
- Azúcar / Endulzante
- Jugos / Refresco
- Agua de sabor
- Sal
- Chile / Salsas
- Caramelos / Chicle
- Galletas / Pastel
- Aguacate
- Gelatina
- Nieve / Helado
- Oleaginosas
- Chocolates
- Papas / Palomitas
- Frutas
- TORTILLAS
- Aceite / Crema
- Mantequilla

Consumo de porciones

Grupo alimentario	Porciones	Energía	Proteína	Lípidos	HCO
Verduras	3	75	6		15
Frutas	3	180			45
Cereales s/g	6	690	18		138
Leguminosas	1	120	8	1	20
POA	5	275	35	15	
Lácteo	1	110	9	6	12
Aceites s/p	4	180		20	
Aceites c/p	1	70	3	5	3
Azúcares	1	40			10
Total	25	1740	79	47	243

Distribución nutricional actual

Macronutriente	%	Kcal	Gramos	g/kg
Proteína				
HCO				
Lípidos				
Totales	100%			kcal/kgPA/d

Interpretación % IAN

Energía	Dieta	%
Proteína	Dieta	%
HCO	Dieta	%
Lípidos	Dieta	%

Evaluación Cualitativa

☐ No ☐ Sí ¿Incluye todos los nutrientes esenciales (HC, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua)? → Completa

☐ No ☐ Sí ¿Los nutrientes están en proporciones apropiadas entre sí? → Equilibrada

☐ No ☐ Sí ¿Los alimentos están libres de microorganismos patógenos, toxinas o contaminantes? → Inocua

☐ No ☐ Sí ¿No se consumen en cantidades excesivas ni contienen excesos de sodio, azúcares o grasas trans? → Equilibrada

☐ No ☐ Sí ¿Cubre los requerimientos energéticos y nutricionales según edad, sexo, actividad física y estado fisiológico? → Suficiente

☐ No ☐ Sí ¿Incluye diferentes alimentos dentro de cada grupo alimenticio a lo largo del día o semana? → Variada

☐ No ☐ Sí ¿Evita la monotonía alimentaria? → Variada

☐ No ☐ Sí ¿Es acorde a los gustos, cultura, hábitos y disponibilidad económica? → Adecuada

☐ No ☐ Sí ¿Está ajustada a su disponibilidad económica? → Adecuada

DIAGNÓSTICOS NUTRICIOS

Paciente masculino de 24 años con diagnóstico nutricional de sobrepeso grado I (IMC 28.7 kg/m²) de etiología primaria por desequilibrio energético positivo, secundario a una ingesta calórica moderadamente superior al gasto energético estimado y a un patrón de actividad física insuficiente para su composición corporal actual. Se identifica adiposidad de predominio central (ICC 0.94, circunferencia de cintura 96 cm) con dislipidemia mixta leve (hipertrigliceridemia y colesterol límite), en presencia de antecedentes hereditarios de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial, lo que incrementa el riesgo cardiometabólico a mediano plazo. No se identifican al momento

OBJETIVO GENERAL

Specific: Reducir el porcentaje de grasa corporal total y el perímetro de cintura, disminuyendo la adiposidad visceral y mejorando el perfil de lípidos séricos.

Measurable: Disminuir 5 kg de peso corporal (aproximadamente 6% del peso actual) y 4 cm de circunferencia de cintura en un periodo de 6

En formato SMART:

- **Specific:** Definición del fenómeno
- **Measurable:** Selección del indicador
- **Achievable:** Evaluación de factibilidad
- **Relevant:** Relación con el problema clínico
- **Time-bound:** Dinámica temporal

Expediente cargado correctamente

Grupos de alimentos y tamaño de porciones recomendadas según el método del Plato del Bien Comer y las equivalencias del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, con énfasis en la identificación de fuentes de grasas

Modelo transteórico del cambio de Prochaska y DiClemente, ubicando al paciente en etapa de contemplación avanzada/preparación para el cambio, dada la motivación expresada y el registro espontáneo de modificaciones

Aplicación (E-2. 1)

Aplicación práctica del conteo de porciones en las tres comidas principales mediante el método del plato dividido (mitad verduras, un cuarto de cereales integrales, un cuarto de proteína magra), con un ejercicio de planeación

Estrategias (C-2. 1)

Establecimiento de metas SMART semanales de menor alcance dentro del objetivo general, automonitoreo mediante diario de alimentos y actividad física, reestructuración cognitiva orientada al manejo de la alimentación asociada

Intervención

Indicación de Alimentos/Nutrientes

Aumentar el consumo de verduras a un mínimo de 5 porciones al día, priorizando verduras de hoja verde y

Sustituir el consumo de refresco y bebidas azucaradas por agua natural, agua de fruta sin azúcar añadida o té

Preferir cereales integrales (avena, arroz integral, tortilla de maíz) sobre cereales refinados y productos de

Controlar el tamaño de las porciones de grasas añadidas (aceites, mantequilla, margarina) utilizando medidas

Requerimiento calórico

Ecuación predictiva

Nombre: Mifflin-St Jeor

Ecuación rápida

Peso: 74 kg

Const. kcal: 25 kcal/kg/d

Total 1850 kcal

Cuadro dietosintético

Macronutriente	%	Kcal	Gramos	g/kg
Proteína	20	370	92	1.2
HCO	50	925	231	3.1
Lípidos	30	555	62	0.8
Totales	100%	1850	385	kcal/kgPt/d

Cálculo de porciones

Grupo alimentario	DES	CM	COM	CV	CENA	RAC	ENERGÍA	PROT.	LÍPIDOS	HCO
Verduras	1	1	1			3	75	6		15
Frutas	1		1	1		3	180			45
Cereales s/g	1	1	2		1	5	690	18		138
Leguminosas			1			1	120	8	1	20
POA	1		2	1	1	5	275	35	15	
Lácteo	1			1		2	110	9	6	12
Aceites s/p	1	1	1	1	1	5	180		20	
Aceites c/p			1			1	70	3	5	3
Azúcares					1	1	40			10
Total							1850	92	62	231
% Adecuación							100	99	101	99

Menú del día

Desayuno	CM	Comida	CV	Cena
Avena cocida con leche descremada, plátano en rebanadas y una pizca de canela, sin azúcar añadida	Manzana verde rebanada con 10 almendras naturales sin sal	Pechuga de pollo asada, arroz integral, ensalada verde con aceite de oliva y 2 tortillas de maíz	Yogurt natural sin azúcar añadida con granola integral y fresas picadas	Quesadillas de tortilla de maíz con queso panela y salsa verde, acompañadas de agua de jamaica sin azúcar

Enrique Reyes — Matrícula 123654852

Mónica Amanche — Docente responsable de Nutrición

Nombre, matrícula y firma del alumno

Nombre, cédula y firma del docente responsable

ESA: Explorado y sin alteraciones; N/A: No aplica; PN: Preguntado y negado; ✓: Adecuado.

4